随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·腹腔感染

（性感认识：压痛、反跳痛、肌紧张）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、腹膜解剖

1.腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等（约 1.5）

①渗出：腹水

②吸收：强大（盆腹膜相对较差）腹膜炎要尽早处理,避免化学性腹膜炎→化脓性腹膜炎,争取6-8h处理

③修复：粘连性肠梗阻 腹膜只要受刺激就会修复,渗出纤维素,纤维素未被完全溶解吸收时就会造成粘连,故难预防

做腹腔引流时,尽量让脓液向下流积聚在盆腔,因为盆腹膜的吸收能力相对较差,不易出现全身中毒的症状

2.间皮细胞

①壁腹膜（体神经支配）：定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧

②脏腹膜（自主神经支配）

定位不准确

二、继发性腹膜炎 感染灶在肚子里面

1.多继发于腹腔空腔脏器穿孔损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）

①腹痛：持续剧烈（**原发部位最显著**）关注原发部位

②标志体征：**腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张）**

③毒素入血：发热、脉快

×腹痛 感染性休克出现三低现象

④病情恶化：**腹胀**加重、脉快但**体温↓**（凉了）、**腹水**炎细胞↑×血中炎细胞

麻痹性肠梗阻越重

大部分外科疾病:先有局部症状→再有全身症状(吸收入血)

e.g 上消化道穿孔

特殊:急性阑尾炎、急性胆囊炎 早期腹痛+发热(吸收入血后更严重)

大部分内科疾病先有全身症状→再有局部症状

e.g 大叶性肺炎

特殊:急性心梗先有胸痛/上腹痛,再由于心肌细胞发生坏死,出现坏死物吸收热

2.腹腔穿刺液特点

①草绿色透明液→结核性腹膜炎

②黄色浑浊含胆汁无臭液→胃十二指肠穿孔 上消化道相对干净

③含淀粉酶血性液→急性重型胰腺炎

④稀薄脓性 ttsx 略臭液→急性阑尾炎

⑤臭味重血性液→绞窄性肠梗阻

⑥不凝血→腹腔内出血（多为实质脏器损伤）实质脏器出血量大,空腔脏器出血量小

抽血不凝固,腹膜有去纤维蛋白的作用

3.治疗

膈肌受压↓

①半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环

②禁食补液、胃肠减压、三代头孢等，休克者需手术探查（右旁正中切口）

导致继发性腹膜炎最常见的是胆囊炎和阑尾炎穿孔,它们刚好都在右边

三、原发/自发性腹膜炎 感染灶不在肚子里面

①血行播散：多为链球菌（如肺部感染灶经血源性到达腹膜），多见于婴幼儿（血联姻）

②上行性：多为淋球菌，多见于女性 女性尿道短宽直

③透壁性：多为大肠杆菌，多见于有腹水的肝硬化（大硬币）

腹水是细菌良好的培养基

④直接扩散